Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 2ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810350

Processo nº 0014424-73.2024.8.17.2001

AUTOR(A): THARCISIO XAVIER DE VASCONCELOS

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc...

THARCÍSIO XAVIER DE VASCONCELOS, devidamente qualificado à inicial, interpôs a presente *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA* contra **BRADESCO SAÚDE S/A**, também qualificada.

De acordo com a inicial, a parte autora é usuária do plano de saúde demandado. Alega foi diagnosticado com sarcoma epitelióide de membro superior direito, que resultou em cirurgia irreversível de amputação do membro superior direito.

Prossegue relatando que evoluiu para lesões secundárias em pulmões, ressecadas em abril de 2023; tendo em novembro de 2023 apresentado novamente metástases pulmonares, igualmente ressecadas.

Afirma que em virtude da gravidade e da evolução da doença, seu médico assistente, Dr. Felipe Marinho (CRM-PE nº 15361), oncologista clínico, solicitou tratamento com PAZOPANIBE (VOTRIENT) 800 mg, com o tempo de uso da medicação até a progressão de doença ou toxicidade limitante, conforme laudo e solicitação juntado aos autos.

Ocorre que, segundo alega o demandante, a seguradora demandada negou a autorização ao argumento de que tratar-se-ia de medicamento não elegível pela DUT ANS 64.

Entende a parte demandante que a conduta da operadora demandada em negar a cobertura ao medicamento solicitado por médico assistente é ilegal, pois vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor.

Diante de todo o exposto, requereu a demandante:

a) a concessão de tutela provisória de urgência para que a operadora seja compelida a autorizar e custear o tratamento do autor com o medicamento VOTRIENT (Cloridrato de Pazopanibe 800 mg), conforme requerido por sua por seu médico assistente, sob pena de multa
pecuniária;

b) a condenação da demandada na obrigação de fazer, com a confirmação da liminar;

c) a condenação da ré nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Juntou procuração e documentos de mérito. Requereu o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela provisória de urgência foi deferida nos termos requeridos (ID 160879052). Na ocasião, o juízo deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Devidamente citada, a demandada ofereceu contestação tempestiva (ID 163893540), na qual impugnou o valor da causa e o benefício de gratuidade da justiça. No mérito, alegou que o contrato celebrado entre as partes estabelece a ausência de cobertura para determinados procedimentos, quando não estiverem constantes no Rol de Procedimentos da ANS. Sustenta a inexistência de obrigação de custeio do exame em razão da ausência de previsão na Diretriz de Utilização (DUT) nº 100 anexa à Resolução Normativa nº 465/2021, motivo pelo qual inexistiria abusividade pela exclusão da cobertura.

Acrescenta que, apesar de estar registrado na ANVISA, não haveria previsão na bula do medicamento para o tratamento da doença da autora. Assim, a solicitação do médico se configuraria como uso *off label* do medicamento, razão pela qual, de acordo com a ANS, a seguradora poderia negar cobertura, por acabar se configurando como tratamento experimental.

Pontua inexistir previsão legal e contratual para fornecimento de medicamento domiciliar.

Alega que com as alterações promovidas na Lei de Planos de Saúde pela Lei Federal n. 14.454/2022, a cobertura de tratamento ou procedimentos fora do rol de eventos e procedimento da ANS só deve ser autorizada caso *"exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico"*; contudo, a parte autora não teria demonstrado a eficácia do medicamento prescrito, necessário para atrair o dever de cobertura. Deste modo, afirma que agiu no exercício regular de um direito reconhecido.

Diante disso, sustenta inexistirem a obrigação de custear o medicamento requerido.

Pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na presente demanda.

Réplica apresentada no ID 182516155.

Intimadas para informar se pretendiam produzir provas, especificando-as, sob pena de preclusão, a parte demandada informou não ter mais provas a produzir (ID 179322313) ao passo que a parte autora nada mencionou em sua réplica.

Comunicação da decisão proferida no Agravo de Instrumento no ID 179338992.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. DECIDO.

Considerando que a matéria discutida é unicamente de direito, sem controvérsias de fato, e que, intimadas, nenhuma das partes requereu a produção de outras provas, entendo que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do *art. 355, I* do CPC.

Antes, porém, de adentrar na análise do mérito da causa, verifico que há questões processuais pendentes de apreciação, haja vista ter a demandada impugnado o valor atribuído à causa, bem assim o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da parte autora.

Sem razão, no entanto. Em interpretação sistemática da norma processual, tem-se que o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Note-se, neste sentido, que o art. 292, §3º, do CPC, determina que o juiz corrija de ofício o valor atribuído pela parte na hipótese em que este não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão da lide:

> Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Igualmente, o valor da causa deve ser atribuído em conformidade ao conteúdo da petição inicial. Nesse sentido, a lição da doutrina: "*Compete ao autor, na petição inicial, fixar o valor da causa, porquanto no momento da propositura da ação (art. 2º) é que esse valor é fixado e estabilizado. Significa que as alterações supervenientes de fato ou de direito são irrelevantes para a atribuição de valor à causa*". (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]/Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 5. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Todavia diante da impossibilidade de aferição exata do proveito econômico em demandada de obrigação de fazer em que se objetiva o fornecimento contínuo e por prazo indeterminado de fármaco, como é o caso discutido nestes autos, entendo que a atribuição do valor da causa deve seguir o disposto no art, 292, § 2º, do CPC o qual dispõe que *"o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações".* Em igual sentido vem decidindo os Tribunais Estaduais:

> PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de "urticária crônica espontânea". Indicação de tratamento com medicamento Xolair (Omalizumabe). Negativa de cobertura sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar e de ausência de previsão no rol da ANS e, consequentemente, no contrato. Sentença de procedência. Irresignação das partes. **Recurso da autora interposto contra o acolhimento da impugnação ao valor da causa. Aplicação da norma do art. 292, § 2º do CPC. Valor da causa que deve corresponder a uma prestação anual do medicamento. Elevação do valor da causa para R$ 52.560,00.** Precedentes. Recusa de fornecimento do medicamento indevida. Abusividade nos termos dos arts. 14 e 51, IV e §1º do CDC. Incidência da Súmula nº 102 do TJSP e do entendimento jurisprudencial nº 5 das teses do "Plano de Saúde I" do STJ. Precedentes desta C. câmara. Elevação dos honorários advocatícios em sede recursal. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ" (TJSP. 3ª Câmara de Direito Provado. Apl. 1116240-56.2017.8.26.0100. Rel. Desembargador Alexandre Marcondes. J. 07.11.2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRESPONDÊNCIA À SOMA DOS VALORES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter. II. **Conforme cediço o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, de modo que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação**.

(TJ-MG - AC: 10133130002560001 Carangola, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PRAZO DETERMINADO SUPERIOR A UM ANO – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ANUAL DO TRATAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECUSA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE) PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – TESE REJEITADA – PREVISÃO LEGAL DE COBERTURA PARA OS MEDICAMENTOS UTILIZADOS COMO ADJUVANTES AO TRATAMENTO DO CÂNCER (RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS)– ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE IMPLIQUEM EM LIMITAÇÃO DE DIREITOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA. CRITÉRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA (ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. **Nos termos do artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil, nas ações que versem sobre obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento, quando o tratamento for superior a um ano, o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual**. 2. O fato de o medicamento prescrito não constar, expressamente, na listagem da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por sua vez, não impede a imposição judicial de seu fornecimento, por se tratar de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à

saúde. 3. Esta Câmara Cível entende que o posicionamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EResp 1.886.929/SP, acerca da taxatividade do rol da ANS, não foi proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual não tem efeito vinculante. 4. Destarte, negar autorização para a cobertura de tratamento que tem probabilidade de êxito no controle dos efeitos da moléstia, fere os princípios da boa-fé, da equidade e da razoabilidade e a própria finalidade básica do contrato, isto é, a preservação da saúde do paciente, colocando-o em posição de extrema desvantagem, em afronta ao artigo 51, IV, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nas ações de obrigação de fazer de natureza condenatória, deve ser observada a ordem de preferência prevista no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, para a determinação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. No caso em apreço, considerando que o custeio do tratamento por prazo determinado tem valor aferível, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação e não o valor da causa. 6. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-PR 00025514520228160103 Lapa, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 24/06/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023) (grifei)

No caso ora discutido, a parte autora valorou a causa em R$ 132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos reais), considerando o valor médio anual do tratamento, conforme orçamento de ID 160680558. O demandado, por sua vez, apesar de questionar dita importância, chegando até mesmo a requerer a realização de perícia atuarial para fixação dos supostos valores devidos, não trouxe aos autos documento que pudesse infirmar os valores apresentados pela parte autora, razão pela qual rejeito à impugnação no que diz respeito ao valor atribuído à causa.

Quanto à alegação da parte demandada de que o demandante não merece o benefício de justiça gratuita por não ter comprovado a sua insuficiência de recursos, entendo que esta não deve proceder. Com efeito, nos termos do §3º do artigo 99 do CPC, é presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, ou seja, a parte insuficiente não tem o dever de comprovar a sua situação de carência de recursos, uma vez que há, para as pessoas naturais, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência.

Caso pretendesse desconstituir a referida presunção, a demandada deveria ter juntado aos autos documentos que confrontassem a alegação de hipossuficiência da autora. Entretanto, não o fez, limitando-se à alegação de que o benefício de justiça gratuita não deveria ter sido deferido.

Cumpre esclarecer que, de acordo com o artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, observe o que preceitua o referido dispositivo: *"§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça*".

Deste modo, rejeito a preliminar.

Assim, superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Trata-se de ação de natureza mandamental, em que se requer a determinação para que a demandada autorize a cobertura do tratamento do autor conforme solicitado pelo seu médico assistente.

Entendo que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação à presente relação jurídica, nos termos da **Súmula 608 do STJ**, pois a relação entre a parte autora e réu se trata de relação de consumo, visto que a demandante era a destinatária final do serviço oferecido pela demandada, e o caso em comento não envolve plano de saúde administrado por entidades de autogestão. De acordo com o referido enunciado sumular: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Desta forma, à luz do microssistema consumerista, passo a analisar a licitude ou não da suposta negativa da operadora demandada em fornecer cobertura ao tratamento solicitado pelo médico assistente do demandante.

Se as obrigações da parte autora com a seguradora encontram-se em dia e existe a necessidade do tratamento solicitado como procedimento de melhoria sua saúde, a negativa da autorização da realização do tratamento em questão vai de encontro ao disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa de Consumidor. Devido a isso, as cláusulas contratuais são passíveis de correção judicial, com o reconhecimento de sua nulidade.

Além disso, verifico que o contrato celebrado entre as partes é um contrato de adesão, uma vez que a parte aderente não tem condições de discutir as cláusulas a serem pactuadas, as quais são redigidas pela seguradora. O aderente apenas tem duas opções: ou assina o contrato, com todas as cláusulas ali dispostas, ou não celebra o contrato.

Se tratando de contrato de adesão, aplicam-se as regras dispostas nos artigos 423 e 424 do **Código Civil**. De acordo com as referidas disposições:

> **Art. 423**. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a **interpretação mais favorável ao aderente**.

> **Art. 424**. Nos contratos de adesão, são **nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio** (grifos nossos).

Nesse sentido, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a cláusula que limita o próprio objeto do contrato de seguro é considerada abusiva. No Resp 135750 – SP, o Min. Relator diferencia cláusulas limitativas de riscos extensivos ou adicionais, relacionados com o objeto do contrato, e as que visam a afastar a responsabilidade da seguradora pelo próprio objeto nuclear da contratação (nos termos do art. 424 do Código Civil, acima citado, cláusulas que estipulam renúncia do aderente a direito resultante da natureza do negócio).

Estas últimas são tidas por abusivas, uma vez que são excludentes da própria essência do risco assumido. A razão de assim se decidir, portanto, decorre da lógica de que o paciente firma um contrato de seguro de saúde para garantir o direito constitucional assegurado e, se o plano restringe os tipos de tratamento que um segurado pode realizar para resolver seus problemas de saúde, em verdade, está impedindo o próprio tratamento das doenças.

Pois bem. Compulsando os presentes autos, tem-se que a necessidade do medicamento pleiteado pela parte autora está fundamentada no relatório médico de ID 160680554, o qual expõe a grave patologia a que a parte autora foi acometida, a ineficácia de tratamentos anteriores e a necessidade da nova medicação aqui pleiteada.

Por seu turno, a ré não indica outro medicamento que atenda à necessidade da parte requerente, disponibilizando tratamento alternativo (com a mesma eficácia), argumentando, tão somente, que não é obrigado a cobrir o tratamento específico com a medicação PAZOPANIBE (VOTRIENT), com fundamento de que a medicação não estaria contemplada nas diretrizes de utilização do medicamento pleiteado (uso *off label*), isto é, para uso diverso daqueles previstos na bula do medicamento e, que não haveria previsão legal para fornecimento de medicamento domiciliar.

Sobre o tema, porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, por ser o médico o único conhecedor da necessidade de seu paciente, cabe somente a ele estabelecer a melhor forma de tratamento e a negativa do medicamento, mesmo nesse caso, reveste-se de ilicitude. **Ressalte-se que o medicamento está devidamente registrado na ANVISA sob o nº** 100681136 (informação obtida em consulta ao site da ANVSA: (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1146607?substancia=25278 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1146607?substancia=25278)), sendo amplamente reconhecido na comunidade médica por sua eficácia no tratamento de diversos tipos de câncer. Trata-se, portanto, de antineoplásico.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes da Corte Superior:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
>
> 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.
>
> 2. **O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segunda o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental**.
>
> 3. Agravo interno não provido.
>
> (STJ. AgInt no AREsp 1567178/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020 – grifo nosso).

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
>
> 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.
>
> 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. **Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label)**. Precedentes.
>
> 3. Agravo interno desprovido.
>
> (STJ. AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020 – grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. **Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)**" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 – grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, fundada na negativa de cobertura de medicamento.

2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.

4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020 – grifo nosso)

Ainda sobre a alegada natureza off-label do medicamento em questão, confira-se trecho extraído de v. acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: "*A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que "não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)", a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora**. Em outras palavras, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico**. **Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo**. (...) A presente hipótese ilustra perfeitamente os riscos que a ingerência da operadora de plano de saúde pode gerar para a vida e a saúde de pacientes. Afinal, parece no mínimo temerário aceitar que a recorrente-UNIMED está autorizada a dizer que a enfermidade da beneficiária do plano de saúde (e aqui devem ser considerados todos os aspectos clínicos e seu histórico de saúde) não deve ser tratada por meio da medicação prescrita pelo médico que a acompanha".* E acrescenta *"o caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. Igualmente, não se identifica o aludido "tratamento experimental" na prescrição médica objeto da presente demanda.* **Em conclusão, (...) pode-se afirmar que a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para se negar ao fornecimento de tratamento ao paciente enfermo, sob o pretexto de que não possui adequação com as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Esta conduta, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98 – o que evidencia a ilegalidade do art. 19, §1º, I, c, da RN 338/13 da ANS – consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).***" (REsp. 1.769.557/CE. 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 13.11.2018. DJe 21.11.2018 – grifo nosso).

Vale a pena destacar que a determinação de cobertura desses medicamentos não gera o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Com efeito, caso a operadora pudesse escolher forma de tratamento do segurado, aí sim haveria quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a seguradora estaria repassando o próprio risco, essencial do negócio que resolveu explorar, para o segurado.

Julgando casos bem semelhantes ao dos autos, que envolveu o medicamento PAZOPANIBE (VOTRINENT) para tratamento de câncer, os tribunais pátrios já se manifestaram nos seguintes termos:

Plano de saúde. Cobertura. Medicamento indicado para tratamento de câncer. "Pazopanibe (Votrinent)". Alegação de ausência de previsão no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei nº 14.454/2022. Existência de prescrição médica. Custeio devido. Precedentes. Dano moral configurado. Indenização devida e bem fixada. Dano material. Alegação de ilegitimidade ativa. Inovação recursal. Pedido não conhecido, na parcela. Recurso não provido, na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 10390572520218260114 Campinas, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Descabimento. Autor portador de hemangioendotelioma epitelióide. Prescrição de medicamento Pazopanibe. Medicamento que já está registrado na ANVISA desde o ano de 2017. Havendo expressa indicação médica, não pode prevalecer negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, ainda que de natureza experimental ou não previstos no rol de procedimentos da ANS. A Lei nº 9.656/98 prevê a possibilidade de exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, excetuando apenas os medicamentos associados a tratamento antineoplásico, caso dos autos. Incidência do inciso I, c e inciso II, g do art. 12 da Lei nº 9.656/98. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10013231720228260272 SP 1001323-17.2022.8.26.0272, Relator: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 21/11/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Assim, a negativa de autorização do tratamento por parte da operadora demandada reveste-se de ilicitude, pois foi devidamente requerido pelo médico da demandante. Não são suficientes para afastar a ilicitude as alegações de que o uso *off label* não geraria a cobertura da medicação pela seguradora, conforme argumentado acima.

Ademais, nos termos da Lei nº 9.656/98, verifica-se ser de cobertura obrigatória aqueles medicamentos ministrados em tratamentos/procedimentos ambulatoriais e durante internação hospitalar, excluída, conforme o artigo 10, VI, desta lei, a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto no artigo 12, nas alíneas c do inciso I (tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes) e g do inciso II (tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar).

Desta feita, não pode prevalecer a recusa da seguradora demandada, sob a alegação de que o medicamento não estaria previsto no Rol de cobertura da ANS, porquanto, conforme dito alhures, compete ao médico indicar o tratamento mais adequado e eficiente ao seu paciente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (AgIn no REsp. nº 2.057.814/SP0 no sentido de que "***a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS É DESIMPORTANTE à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa".*** Assim, ainda que se considere a natureza taxativa do Rol da ANS tal fato não tem relevância quando se está diante requerimento de custeio ou fornecimento de medicamento associado a tratamento quimioterápico. Em igual sentido:

> CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
>
> 1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
>
> Decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça reconsiderada.
>
> 2. "**É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim**.
>
> Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
>
> 3. **No caso em exame, todavia, o fármaco prescrito pelo médico assistente é um antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, com expressa indicação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde, com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem a devida indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente**.
>
> 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.705.037/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.

2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração.

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da necessidade da prova requerida - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

4. **Consoante entendimento desta Corte Superior, "a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa".**

5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO.

1. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em cerceamento de defesa demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. **É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.**

5. **De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label**.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.614.397/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (grifei)

Por todo o exposto, tem-se que a negativa para a autorização para fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente reveste-se de ilicitude, sendo forçoso reconhecer a responsabilidade do plano réu no que diz respeito ao dever de custear o tratamento da parte autora, conforme requerido em laudo médico.

Por todo o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela provisória deferida (ID 160879052), em todos os seus termos, inclusive no que tange a multa, **JULGO PROCEDENTE** o pedido autoral para condenar a ré a arcar com o custeio do medicamento PAZOPANIBE (VOTRIENT) 800 mg, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (conteúdo patrimonial da obrigação de fazer), com as correções de direito.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife, datado e assinado eletronicamente.

Assinado eletronicamente por: ROGERIO LINS E SILVA
29/10/2024 13:50:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 186693714

24102913501976800000182077120

IMPRIMIR GERAR PDF